

CAPÍTULO 7.8

Hipotiroidismo en el Embarazo

PERFIL EUNACOM 1.03.1.006
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Síndrome de Cushing

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Síndrome de Cushing ≠ Enfermedad de Cushing. - **Síndrome de Cushing** = hiper cortisolismo de cualquier causa - **Enfermedad de Cushing** = tumor hipofisario productor de ACTH (una de las causas del síndrome)

Causas (de más a menos frecuente)

- **Corticoides exógenos** (iatrógeno — la más frecuente de todas)
- **Enfermedad de Cushing** (tumor hipofisario productor de ACTH)
- **Adenoma suprarrenal** (tumor suprarrenal hiperproductor de cortisol)
- **Hiperplasia suprarrenal**
- **Síndrome de ACTH ectópica** (cáncer de pulmón de células pequeñas que produce ACTH)

Clínica

TABLA 7.8.1: SÍNTOMA / SIGNO VS NOTA		
SÍNTOMA / SIGNO	NOTA	
Astenia	Más frecuente (pero inespecífico)	
Obesidad centripeta	Abdomen, espalda alta ("búfalo"), cara de luna	
Estrías violáceas	Color vino tinto, anchas (> 1 cm)	
Atrofia muscular	Extremidades delgadas con tronco obeso	
Hipertensión secundaria	Por exceso de aldosterona y/o cortisol	
Diabetes	Por efecto antiinsulínico del cortisol	
Osteoporosis	Riesgo de Fracturas: Generalidades	fracturas
Hirsutismo en mujeres	Por andrógenos adrenales	
Infecciones	Inmunosupresión → primera causa de muerte	

Exámenes alterados

- **Hipocalcemia** (K bajo)
- **Hiperglicemia** (o diabetes)
- **Alcalosis metabólica** (lo contrario a la **insuficiencia suprarrenal**)

Diagnóstico — 3 Pasos

Paso 1: Confirmar hiper cortisolismo (cualquiera de los 3)

TABLA 7.8.2: EXAMEN VS RESULTADO ANORMAL	
EXAMEN	RESULTADO ANORMAL
Cortisol libre en orina de 24 h	↑
Cortisol en saliva nocturna	↑
Prueba de supresión corta con dexametasona	Cortisol no suprime al dar 1 mg de dexametasona

→ Si 2 exámenes alterados (o 1 muy alterado) → confirma hiper cortisolismo → ir al paso 2

Paso 2: Localizar la causa — ACTH y prueba de supresión larga

TABLA 7.8.3: ACTH VS PRUEBA SUPRESIÓN LARGA		
ACTH	PRUEBA SUPRESIÓN LARGA	CAUSA
↑	Suprime	Enfermedad de Cushing (hipofisaria)
↑	No suprime	ACTH ectópica (cáncer de pulmón)
↓	No suprime	Suprarrenal (adenoma / hiperplasia)

Paso 3: Imágenes para localizar el tumor

TABLA 7.8.4: SOSPECHA VS IMAGEN	
SOSPECHA	IMAGEN
Causa hipofisaria	RNM de hipófisis
Causa suprarrenal	TAC/RNM de suprarrenales
ACTH ectópica	Rx de tórax → TAC de tórax (buscar tumor pulmonar)

Tratamiento

TABLA 7.8.5: CAUSA VS TRATAMIENTO	
CAUSA	TRATAMIENTO
Corticoides exógenos	Reducir dosis gradualmente
Enfermedad de Cushing	Cirugía (adenomectomía hipofisaria)
Adenoma suprarrenal	Cirugía (suprarrenalectomía unilateral)
Hiperplasia suprarrenal bilateral	Cirugía bilateral + sustitución con hidrocortisona + fludrocortisona

| ACTH ectópica | Tratar el tumor primario |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Mujer de 28 años con hipotiroidismo primario compensado con Levotiroxina 75 mcg/día confirma embarazo de 6 semanas mediante test de orina. Consulta qué hacer con su tratamiento."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Hipotiroidismo en el Embarazo: el feto depende de la T4 materna en el primer trimestre para el desarrollo neurocognitivo. Apenas se confirma el embarazo, la paciente debe AUMENTAR la dosis de Levotiroxina en un 30-50% (ej. tomar 2 comprimidos adicionales por semana). Metas de TSH: < 2.5 mUI/L en 1er trimestre y < 3.0 mUI/L en 2do y 3er trimestre. Control de TSH cada 4 semanas hasta la semana 20.

- PUNTOS CLAVE DESTACADOS**
- Screening con TSH a todas las embarazadas. Objetivo: TSH 0,4-2,5 (más estricto que 0,4-4).
 - TSH >4 + T4 libre normal en embarazo = subclínico → tratar sí o sí (riesgo de daño neurológico fetal).
 - TSH 2,6-4 en embarazo = zona gris, discutible si tratar o no.
 - Hipotiroidismo previo + embarazo: aumentar dosis en 30% y ajustar para TSH <2,5.
 - Las hormonas tiroideas son relativamente seguras en el embarazo.
 - El riesgo de daño cerebral fetal justifica ser más agresivo en el control tiroideo.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (HIPOTIROIDISMO EN EL EMBARAZO)

PREGUNTA 1

Embarazada de 8 semanas con TSH 5,2 mU/L y T4 libre 0,9 ng/dL (normal). ¿Cuál es la conducta?

- A)** Observar, TSH casi normal
- B)** Iniciar levotiroxina
- C)** Repetir exámenes en segundo trimestre
- D)** Solicitar anticuerpos anti-TPO antes de decidir
- E)** Derivar a endocrinología sin tratar

RESUMEN: HIPOTIROIDISMO EN EL EMBARAZO

El hipotiroidismo en el embarazo es importante porque se asocia a daño en el desarrollo cerebral del feto. Se hace screening con TSH a todas las embarazadas. El objetivo de TSH es más estricto: 0,4-2,5 (no 0,4-4). Los requerimientos de hormonas tiroideas aumentan durante el embarazo. Interpretación del screening: TSH <2,5 + T4 libre normal = embarazo sano, observar. TSH 2,6-4 + T4 libre normal = zona gris, discutible si tratar. TSH >4 + T4 libre normal = subclínico, tratar sí o sí. TSH >4 + T4 libre baja = hipotiroidismo franco, tratar con levotiroxina. Si tiene diagnóstico previo de hipotiroidismo y se embaraza: aumentar dosis en 30% y ajustar para TSH entre 0,4-2,5.